

Venere — Format Playbook operativo

Tutto ciò che si applica a ogni clinica. Ripetibile. Riservato.

AGGIORNAMENTO (settembre 2026) • decisioni e novità recepite - Regime = AMBULATORIO. In Lombardia la maggior parte dei trattamenti (iniettivi + laser medicali 3B-4) richiede l'**ambulatorio** (autorizzazione all'esercizio del Comune + parere/sopralluogo ATS via ASAN), non lo studio medico (solo non invasivo). Il target è il centro estetico **convertibile in ambulatorio** (~90-120 mq, locali distinti, meglio indipendente). - **Architettura hub & spoke:** ambulatori hub (invasivo, alto margine, apertura al chirurgico) + studi medici satellite (non invasivo, funnel, capex ridotto). - **Medici condivisi + vincolo DS:** un direttore sanitario può coprire max 3 strutture in Lombardia (vincolo di ore); serve un DS per cluster a scala. Marcello Cammalleri (chirurgo maxillo-facciale) è CMO + DS + responsabile clinico rete. - **Capex conversione più alto** per l'ambulatorio (indicativamente ~€250-450k/sede) e tempi autorizzativi più lunghi. - **Bacino:** ~43.000 centri estetici in Italia, ~1.000-1.900 idonei ad ambulatorio. Vedi `Venere_Fattibilita_Ambulatori.md`.

Come usare questo playbook

È la lista completa delle mosse che trasformano una clinica acquisita (o il pilota) nel formato Venere, in **~100 giorni**. La prima clinica è il **format lab**: qui si testa e si codifica; poi si **ripete identico** su ogni acquisizione. Ogni blocco ha **Cosa • Mosse • Target**.

Parte 0 — Il motore del roll-up: convertire i centri estetici in ambulatori

Questa è la messa a fuoco principale del progetto: ciò che rende il roll-up fattibile e veloce dove gli altri (Klinicy, Faceland) vanno lenti e cari.

La mossa: non partire dalle poche cliniche mediche in vendita (scarse, care, contese). Partire dai **centri estetici** (platea ~43.000 (~1.000-1.900 idonei ad ambulatorio), economici, con clientela e footfall già attivi) e **aggiungere la medicina estetica**. Due playbook industrializzati tolgono i due colli di bottiglia.

Motore 1 — Playbook autorizzazioni (rende *fattibile*)

L'autorizzazione sanitaria della sede è lo step lento e variabile: va **industrializzato**. - **Filtro di convertibilità pre-deal** (nella scorecard, prima di firmare): destinazione d'uso urbanistica compatibile/variabile; locali adeguabili ai requisiti (DPR 14/1/1997 + norme regionali: dimensioni, servizi igienici accessibili, sterilizzazione, rifiuti sanitari); autorizzabilità come **ambulatorio** con direttore sanitario. - **Template di "sede medica"**: layout standard delle sale mediche, capitolato dei lavori, spec dispositivi → capex ripetibile (~€150-300k/sede). - **Partner regolatorio-sanitario a contratto** + relazioni rodiate con **ATS/Comune** (in Lombardia: Comune + ATS Milano). - **Obiettivo:** trasformare un iter bespoke di **mesi** in un processo **ripetibile di settimane**. Chi padroneggia l'autorizzazione-a-scala converte più in fretta di chiunque: è un moat operativo.

Motore 2 — Medici condivisi tra i centri (rende *veloce e scalabile*)

Il medico è il collo di bottiglia: non trovi un medico dedicato per ogni sede. - **Pool di medici che ruota part-time** su più centri (come già fa Marcello a Milano/Verona): converti in ambulatorio **molte sedi con pochi medici**. - Ogni sede è **subito profittevole** (niente costo di un medico full-time); il non-medico del centro **paga l'affitto** mentre converti in ambulatorio. - **Depersonalizzazione by design**: il paziente è fedele al **brand e al percorso**, non al singolo medico → è ciò che fa scattare il multiplo. - **Governance obbligatoria**: protocolli condivisi + **comitato scientifico** per qualità costante su medici che ruotano; direttore sanitario per sede (in Lombardia un DS copre max 3 strutture per vincolo di ore: serve un DS per cluster a scala); gestione della responsabilità clinica e dei contratti medici.

Il compounding (perché il roll-up "rotola")

Centro estetico (footfall + cash non-medico) + medico condiviso (margine alto, costo fisso basso) + playbook autorizzazioni (replica sede dopo sede) = **ogni conversione è un'unità piccola, economica, veloce e ripetibile**. È così che il roll-up scala davvero, invece di arenarsi su acquisizioni mediche bespoke.

Gli "se" da provare (gate prima di scalare)

- **Tasso di conversione beauty** → **medico**: da misurare su **1-2 sedi** (o sui pazienti di Marcello) prima di scalare. È la variabile che fa o rompe l'economia.
- **Convertibilità autorizzativa**: non tutte le sedi sono convertibili → il filtro pre-deal scarta quelle con vincoli urbanistici.
- **Qualità dei medici condivisi**: protocolli + audit + comitato scientifico per non perdere qualità con la rotazione.

Sequenza: prova l'unità di conversione (autorizzazione + tasso + capex) su 1-2 sedi → **poi** scala aggressivo sulla platea dei centri estetici. Il focus è **solo** convertire i centri estetici in ambulatori: le cliniche mediche già avviate **non** sono in focus.

Parte 1 — I 12 blocchi del format

A. Percorsi di cura ricorrenti (il cuore del recurring)

Cosa: piani di trattamento annuali definiti dal medico su indicazione clinica, a **pagamento mensile**. Recurring che nasce dalla prescrizione, non dalla promozione (deontologicamente pulito). **Mosse**: - Con Marcello, **codifica 3-5 percorsi standard** (indicazione, sequenza trattamenti, follow-up, prezzo unico, rata mensile). Es. "*Skin Quality 12 mesi*": 2 biostimolazioni + 1 ciclo energy-based + skincare trimestrale + 4 follow-up → **~1.900€, 159€/mese × 12**. - Percorsi anche per *rimodellamento/skin quality post-GLP-1* e *anti-aging/preventivo*. - Fatturazione mensile; in caso di recesso il paziente **paga solo quanto erogato** (nessun prepagato). **Target**: **15-20% ricavi ricorrenti a 24 mesi**, 30% a regime.

B. Membership non medica (l'entry point ricorrente)

Cosa: abbonamento mensile su **servizi non medici** (skincare medicale, dermo-analisi periodica, consulenze, follow-up, priorità di accesso). Qui benefit/vantaggi sono liberi. **Mosse:** definisci 1-2 tier (**39-59€/mese**), benefit, fatturazione ricorrente su carta. È l'ingresso che alimenta i percorsi. **Target:** % pazienti attivi in membership; conversione membership → percorso. **Linea rossa:** mai sconti/crediti/promozioni su atti medici.

C. Pagamenti rateali (financing) — motore di sbiancamento + mercato

Cosa: rateizzazione **a tasso zero** sui percorsi (al posto dei pacchetti prepagati). **Mosse:** - Convenzione con una **finanziaria** (consumer credit / BNPL sanitario: es. Compass, Cofidis, Findomestic, Pagolight/Soisy). - **POS + financing al punto vendita**; la beauty advisor presenta **la rata mensile**, non il prezzo pieno. - Effetto triplo: **alza il ticket, apre la fascia 25-40, rende il ricavo tracciabile (bianco)**. **Target:** % percorsi finanziati; uplift ticket medio.

D. Patient journey da retail (beauty advisor + consulenza + recall)

Cosa: l'esperienza premium che uno studio individuale non ha. **Mosse:** - **Beauty advisor dedicata** (non medico): accoglienza, consulenza strutturata, presenta percorsi/rata, follow-up, upsell membership. **Non vende atti medici** — il medico prescrive. - **Flusso di consulenza codificato:** dermo-analisi → obiettivi → criteri di esclusione → piano medico → proposta economica. - **Recall automatici + follow-up sistematico + riattivazione dormienti** (dal gestionale). **Target:** **tasso di conversione consulenze**; retention a 6 mesi.

E. Multi-provider by design

Cosa: 2+ medici con protocolli condivisi; il paziente è fedele al **brand e al percorso**, non al singolo. **Mosse:** recluta un **secondo medico** (network di Marcello); implementa protocolli condivisi; **satura le agende** su più provider. **Target:** n° provider attivi; % pazienti gestiti da ≥2 medici (indice di depersonalizzazione).

F. Mix clinico completo

Cosa: iniettabili + dispositivi energy-based + medicina rigenerativa + percorsi post-GLP-1. **Mosse:** **gap-analysis** del menù attuale vs format; aggiungi le categorie mancanti (capex dispositivi, formazione, protocolli); **cross-sell** tra categorie → più visite/anno. **Target:** categorie per paziente; visite/anno per paziente.

G. Gestione manageriale + KPI

Cosa: la clinica gestita come cruscotto, non come racconto. **Mosse:** **GM di area** (condiviso sul cluster) sul P&L; **dashboard KPI settimanale:** saturazione agende, conversione consulenze, retention, % recurring, ricavo per ora-medico e per sede; **review settimanale**. **Target:** saturazione agende; EBITDA/sede.

H. Gestionale + data layer (moat + data play)

Cosa: il sistema che rende il format replicabile e misurabile. **Mosse:** **instrumenta la cattura dati dalla clinica #1** — foto before/after standardizzate, mappe di iniezione, parametri device, **outcome 30/90/180**, consensi + GDPR by design. **Sistema interim off-the-shelf** ora; **Diana industrializza post-closing** (gestionale proprietario). Motore di **recall/retention**. **Target:** % casi tracciati con outcome; completezza dataset.

I. Procurement centralizzato

Cosa: sconti volume su iniettabili e dispositivi. **Mosse:** **contratti centralizzati** coi produttori (AbbVie/Allergan, Galderma, Merz) per **sconti volume 10-20%**; **partnership La Farmacia** per scala d'acquisto anticipata + logistica (consumabili/skincare). **Target:** costo iniettabili/trattamento; contributo al margine (20% → 27%).

J. Marketing / brand

Cosa: brand nazionale + marketing di gruppo al posto di quello locale. **Mosse:** presenza digitale, CRM, campagne — **comunicazione solo informativa** (nessun claim di risultato). Sostituisce lo spend locale della clinica. **Target:** costo acquisizione paziente; nuovi pazienti/mese.

K. Compliance / governance clinica (i paletti)

Cosa: ciò che protegge brand e multiplo (rischio n°1). **Mosse:** **struttura MSO** (gestione separata dall'atto medico), **direttore sanitario** per sede, comunicazione informativa; **comitato scientifico indipendente**; **incentivi mai sui volumi**; **audit + mystery patient**; **KPI reputazionali con soglie di blocco**. Nero → bianco: **fatturazione/POS integrale**, financing tracciabile, **zero sconti cash su atti medici**. **Target:** NPS/recensioni; zero incidenti reputazionali.

L. Academy / onboarding

Cosa: far adottare il format in 100 giorni. **Mosse:** **academy digitale** per medici e beauty advisor; **playbook di integrazione a 100 giorni** codificato nel software. **Target:** giorni all'adozione piena del format.

Parte 2 — Sequenza sulla prima clinica (cosa testare, dove)

Parte "domanda" (testabile subito, anche sui pazienti di Marcello, senza acquisizione): percorsi ricorrenti (A), membership (B), financing (C), beauty advisor + consulenza + recall (D), KPI (G), cattura dati interim (H). → provi **adozione recurring, conversione, ticket, retention**.

Parte "scala" (richiede una clinica acquisita e convertita): multi-provider/depersonalizzazione (E), procurement a volume (I), GM di area (G), brand di gruppo (J). → provi **che il valore non dipende dal singolo medico** e l'uplift di margine.

Ordine pratico sulla clinica #1: (1) governance/compliance + gestionale interim → (2) percorsi + membership + financing → (3) beauty advisor + consulenza + recall → (4) secondo medico + mix clinico → (5) procurement + KPI + brand.

Parte 3 — La scorecard del "format provato"

Soglie che dichiarano il format validato e fanno scattare la **scala per acquisizioni**: - [] **Recurring** ≥ **10-15%** dei ricavi della clinica - [] **EBITDA/sede +30%** vs pre-format (verso 27% di margine) - [] **Conversione consulenze** a target (definire baseline → +X%) - [] **Retention a 6 mesi** dei pazienti su percorso ≥ target - [] **Ticket medio** +X% con financing - [] **≥2 provider** attivi con pazienti fedeli al brand (depersonalizzazione dimostrata) - [] **Dataset** outcome popolato e recall engine funzionante - [] **Zero criticità reputazionali/deontologiche**

Raggiunte → il format è **codificato e replicabile** → parti con le acquisizioni del cluster.

Parte 4 — Il playbook a 100 giorni (timeline)

- **Giorni 0-15**: governance (direttore sanitario, MSO, compliance), gestionale interim, fatturazione/POS integrale, baseline KPI.
- **Giorni 15-45**: lancio **percorsi + membership + financing**; onboarding **beauty advisor** e flusso di consulenza; attivazione **recall**.
- **Giorni 45-75**: **secondo medico** + protocolli condivisi; **mix clinico** ampliato; **procurement** centralizzato.
- **Giorni 75-100**: **brand/marketing** di gruppo; dashboard KPI a regime; **review** vs scorecard "format provato".

Ogni clinica successiva ripete questo playbook: è la macchina replicabile che i consolidatori chiamano "100-day integration".

Parte 5 — La macchina AI-driven: dove l'AI crea valore (operations + M&A)

Il modello Bending Spoons applicato a Venere: la piattaforma centrale è il prodotto, l'AI la rende scalabile con HQ minimo. Non solo far girare le sedi, ma Alzare l'intera macchina (origination, DD, integrazione, operations e portafoglio) su un unico layer AI-native. Salvatore Diana è l'architetto di questo layer.

Regola d'oro: l'atto medico resta al medico (l'AI misura e supporta, non decide). Tutto il resto (coordinamento, analisi, decisioni commerciali e di deal) è terreno degli agenti.

Legenda orizzonte: ● fattibile oggi (LLM/agenti pronti) · ● medio (serve dataset del gruppo) · ● lungo (regolatorio/automazione).

5A. La macchina operativa AI-native (far girare le sedi)

Dove l'AI crea valore, mappato sui blocchi del format:

- **Agende e no-show** ●: agente che ottimizza la **saturazione**, prevede i no-show e gestisce overbooking/liste d'attesa. (*Blocco G*)
- **Recall e retention** ●: identifica i dormienti, sceglie **tempistica, canale e messaggio** ottimali per paziente, innescato dagli outcome 30/90/180. (*Blocchi D, H*)

- **Conversione beauty → medico** ●●: **il punto che vale di più per la tesi**: modello che scora i clienti del centro estetico per **propensione a passare al medico** → targeting chirurgico dell'upsell. Trasforma il tasso di conversione da speranza a leva gestita.
- **Consulenza / beauty advisor copilot** ●: struttura la consulenza, propone il **percorso giusto** e la rata, genera script personalizzati (decision-support *commerciale*, non clinico). (*Blocco D*)
- **Pricing e financing** ●●: ottimizza prezzo/rata dei percorsi per **coorte e propensione**; massimizza ticket e conversione al financing. (*Blocchi A, C*)
- **Procurement** ●●: previsione consumi per sede, ordini/scorte ottimizzati, negoziazione data-driven coi fornitori. (*Blocco I*)
- **Cruscotto KPI agentic** ●: monitora saturazione, conversione, retention, % recurring, ricavo per ora-medico **per sede e per medico**, con alert e ipotesi di causa. (*Blocco G*)
- **Marketing/CRM** ●: contenuti conformi (solo informativi), targeting, attribution, riattivazione. (*Blocco J*)
- **Back office / HR / amministrazione** ●: agenti che fanno il **lavoro di coordinamento** (fatturazione, turni, onboarding): è ciò che tiene l'**HQ snello** (il punto Bending Spoons).
- **Compliance e reputazione** ●●: monitoraggio recensioni/NPS, **mystery patient** assistito, flag reputazionali con soglie di blocco. (*Blocco K*)
- **Decision-support clinico** ●: sul dataset del gruppo l'AI **suggerisce** piano/dosaggio/protocollo; standardizza la qualità e riduce la dipendenza dal singolo medico. *Il medico decide.* (*Blocco H, data play*)
- **Rostering dei medici condivisi** ●●: **ottimizzazione AI di chi va dove e quando** sui centri: è il motore che rende scalabile il modello "medici condivisi" (Parte 0). Massimizza ore-medico produttive minimizzando spostamenti.

5B. La macchina M&A AI-native (la parte "Bending Spoons": origination → DD → integrazione → portafoglio)

Qui sta la novità: **Alzare tutto il deal-making**, non solo le operations.

- **Origination e scoring** ●: pipeline che ingerisce **AIDA/Cerved + registri regionali + segnali pubblici** (recensioni, volumi fornitori, età/anzianità del titolare) e **scora i target sulla scorecard** in automatico → ranking A/B/C, aggiornato di continuo. Da ricerca manuale a **motore di sourcing**.
- **Filtro di convertibilità autorizzativa** ●: modello/checklist che scora la sede su **destinazione d'uso (da visite/catasto), requisiti strutturali, autorizzabilità ad ambulatorio** → dice in ~48h se è convertibile. **Attacca il collo di bottiglia n°1** del piano.
- **Dossier e outreach** ●: per ogni target genera **dossier, angoli e messaggi personalizzati**; prepara al team le "vie calde". (*Il primo contatto resta warm e umano; l'AI arma la preparazione.*)
- **Due diligence** ●●: analisi documentale automatica (bilanci, contratti, autorizzazioni), **normalizzazione EBITDA**, red flags, **stima del nero** (gap cassa/POS/consumi vs fatturato), Q&A sui documenti del data room.
- **Valutazione e struttura del deal** ●●: genera l'offerta (cash/rollover/earn-out) e **simula gli scenari** (conversione bassa/media/alta, tempi di autorizzazione, capex) per ogni target → decisione fondata, non a naso.
- **Integrazione a 100 giorni** ●: il playbook **codificato nel software**: agenti che assegnano, eseguono e **monitorano i task** per sede; **academy AI** per onboarding di medici e beauty advisor.

Ogni conversione parte già "strumentata".

- **Gestione di portafoglio** ●●: come BS gestisce molte app da un centro: **benchmarking cross-sede**, individuazione delle sedi sotto-performanti, allocazione ottimale di risorse e **medici condivisi** guidata da un agente.

5C. Perché è un vero valore aggiunto (e non marketing)

- **HQ minimo, scala massima**: l'AI fa il coordinamento che altrove richiede middle-management → **più sedi per persona di HQ**. È il moltiplicatore Bending Spoons.
- **M&A più veloce ed economico**: sourcing e DD Alzzati abbassano costo e tempo per deal → puoi lavorare **l'platea da ~43.000** invece delle poche cliniche visibili.
- **Il moat che la finanza non compra**: origination-engine + dataset di outcome + decision-support sono ciò che Klinicy/Faceland (medical-first, finanziari) **non** hanno. È la ragione per cui il roll-up deve essere di *questo* team.
- **Il ponte all'automazione** (●): ogni dato raccolto oggi è substrato per l'automazione futura delle procedure standardizzate → sposta l'exit da multiplo *healthcare-services* verso *AI-platform*.

Guardrail: partire dal ● (valore da subito, basso rischio), costruire il ● man mano che il dataset cresce, tenere il ● come optionality. Non far dipendere la Fase 1 dall'AI avanzata: il roll-up "noioso" (conversione + formalizzazione + recurring) deve reggere da solo; l'AI lo rende **più snello, più veloce e più difendibile**.